

Recomendações da SPCPTGI para orientação diagnóstica e terapêutica de mulheres com teste de rastreio do cancro do colo do útero alterado num contexto de pandemia COVID 19⁽¹⁾

Face à situação atual, sem precedentes, da pandemia COVID-19 e à necessidade de suspender/adiar as consultas e procedimentos eletivos sem caráter de urgência, a SPCPTGI recomenda as seguintes orientações, no âmbito da patologia cervical:

1. Mulheres com teste de rastreio positivo de baixo risco de HSIL/ invasão [citologia ASC-US, LSIL ou HPV AR+ (não 16/18) com citologia reflexa ASC-US/ LSIL]: adiar avaliação diagnóstica até 6-12 meses.
2. Mulheres com teste de rastreio positivo de alto risco de HSIL (ASC-H, HSIL, AGC, HPV + 16 ou 18*) devem ser contactadas e agendada avaliação diagnóstica dentro de 3 meses

*Face a um teste HPV 16 ou 18 positivo sugere-se, se necessário, a realização de citologia reflexa para permitir reestratificação do risco
3. Mulheres com HSIL sem suspeita de invasão devem ser contactadas e agendado tratamento dentro de 3 meses
4. Mulheres com suspeita de doença invasiva devem ser contactadas e avaliadas em consulta num prazo de 2 a 4 semanas desde a referenciação

Estas orientações surgem dos constrangimentos face à atual contingência com que as instituições se deparam. A orientação deve ser individualizada em casos selecionados e em função da disponibilidade das unidades de colposcopia.

Uma vez contido o surto de COVID-19, as mulheres provenientes do RCCU com testes positivos devem ser novamente orientadas e tratadas de acordo com as recomendações nacionais e institucionais previamente existentes.

SPCPTGI, 26/3/2020